Talk.M3D

Manual do Investidor

Tese, produto, mercado, modelo de negócio, roadmap e playbooks de go-to-market e operação.

Sumário

1	Sumário executivo	2
2	Problema e oportunidade de mercado	3
3	O produto: o que já existe	4
4	Modelo de negócio e economia da unidade	5
5	Playbook de go-to-market	7
6	Playbook de implantação e operação	10
7	Roadmap de 18 meses	12
8	Regulação, segurança e conformidade	14
9	Riscos e mitigação	15
10	Uso dos recursos e governança	16
11	Due diligence e fontes	17

Atenção: Como ler os números. O que descreve o produto vem do código e da configuração reais. Dados de mercado são de fontes públicas, citadas no capítulo 11. Valores de receita são **simulações aritméticas ilustrativas** a partir dos preços de tabela, não projeções nem resultados. Itens marcados **[preencher]** dependem de informação dos fundadores (tração, equipe, rodada). Este documento não é parecer jurídico nem oferta de valores mobiliários.

Campos que os fundadores precisam completar

Item	Onde entra	Situação
Time (fundadores, cargos, histórico)	Cap. 10	[preencher]
Tração real (usuários, clínicas, receita, retenção)	Cap. 1 e 4	[preencher]
Tamanho e instrumento da rodada, valuation	Cap. 10	[preencher]
Cap table e acordos societários	Cap. 11	[preencher]
Contratos, DPO, políticas de privacidade assinadas	Cap. 8 e 11	[preencher]

1 Sumário executivo

A tese em uma página

Talk.M3D é uma plataforma de comunicação e cuidado para clínicas e profissionais de saúde: conversa em tempo real com tradução, agenda inteligente, teleconsulta, prontuário com IA de apoio (sempre com aprovação humana), receitas com QR verificável, rotinas de reabilitação, financeiro, créditos/planos e auditoria à prova de adulteração, em uma única interface que parece um mensageiro conhecido e é **instalável como aplicativo**.

4	5	11	158	40
planos de assinatura (Básico grátis a Clínica)	idiomas na interface (pt, es, guarani, en, zh)	perfis de acesso (paciente a root)	rotas de API documentadas	tabelas, dados sensíveis cifrados

Por que agora

- A teleconsulta deixou de ser emergência e virou rotina: no Brasil ela é regulada pelo CFM (Resolução 2.314/2022) e o mercado de telemedicina é estimado em **US$ 2,4 bi em 2025, com projeção de US$ 12,9 bi em 2034 (CAGR 20,5%)** por consultoria independente (IMARC).
- A IA entra na prática clínica com regras claras de supervisão humana (CFM, 2026) e de produto (Anvisa, RDC 657/2022): quem nasce com **rascunho + aprovação + trilha de auditoria** está alinhado ao caminho regulatório.
- Clínicas pequenas e médias ainda operam com WhatsApp, planilhas e vários sistemas sem integração, sem trilha de auditoria e com risco de privacidade.

Diferenciais comprovados no produto

Diferencial	Como aparece no produto
Privacidade por desenho	AES-256-GCM em mensagens, transcrições, notas e prontuário; nome do paciente removido antes de ir à IA; acesso só a pacientes vinculados
IA com responsabilidade	Tudo é rascunho; só entra no prontuário após aprovação; falha de um provedor troca para outro (failsafe) e o atendimento segue
Auditoria verificável	Cadeia de hash imutável por gatilho do banco, com verificação pela tela
Aquisição embutida	Tokens de convite, programa de embaixadores e indicação premiada com créditos
Implantação independente	Instalador no navegador, roda em um servidor próprio (VPS, Docker ou Kubernetes) sem arquivo de configuração manual
Latam-ready	Interface em português, espanhol, guarani, inglês e chinês; diretrizes por país

Estado atual: produto funcional (versão 7) com manuais de usuário e técnico, testes automatizados da lógica e instalação em servidor próprio em curso. **Pendente antes de escalar:** homologação em banco e Docker reais, piloto com clínicas e validação regulatória (cap. 7 e 8). Tração comercial: **[preencher]**.

2 Problema e oportunidade de mercado

Quem sofre, quanto vale e onde entrar

Dores do profissional e da clínica

Dor	Consequência	Resposta do Talk.M3D
Comunicação fragmentada (WhatsApp, telefone, e-mail)	Perda de histórico, risco de vazamento, sem trilha	Chat cifrado, canais internos e urgência destacada
Faltas e remarcações	Agenda ociosa e receita perdida	Risco de falta por consulta e lembrete por SMS (24 h ou 48 h)
Teleconsulta sem registro estruturado	Retrabalho de prontuário	Transcrição com consentimento, rascunho estruturado e relatório CARE
Receitas e rotinas em papel ou imagem	Uso indevido, sem verificação	QR com validade e usos máximos, baixa registrada, verificação do médico
Gestão manual (financeiro, equipe, acessos)	Erros e risco de privacidade	Financeiro, perfis, bloqueio/desbloqueio, auditoria
Barreira de idioma e região	Exclusão de pacientes	Cinco idiomas e tradução por mensagem

Tamanho de mercado (fonte externa)



Figura 2.1 · Mercado de telemedicina no Brasil, estimativa IMARC (US$ 2,4 bi em 2025; US$ 12,9 bi em 2034; CAGR 20,52% em 2026–2034). Estimativas de consultorias variam e devem ser tratadas como ordem de grandeza.

Onde entrar primeiro (ICP)

Segmento	Por que	Plano de entrada
Clínicas de fisioterapia e reabilitação	Rotinas de exercício, evolução da dor (EVA), pacotes de sessões e retorno recorrente: o produto cobre o ciclo inteiro	Profissional ou Clínica
Consultórios multiprofissionais pequenos (2 a 15 pessoas)	Falta de sistema único; sensíveis a preço e à facilidade	Essencial a Clínica
Profissionais autônomos	Entrada barata, forte indicação	Básico e Essencial
Programas de saúde em região de fronteira e Mercosul	Interface em espanhol e guarani, tradução e diretrizes por país	Clínica, via parceiro local

Dica: O ICP (perfil de cliente ideal) acima é uma **hipótese a validar** no piloto do capítulo 5. Os critérios de validação estão no playbook.

3 O produto: o que já existe

Funcionalidades prontas e maturidade

Módulo	O que entrega	Maturidade
Mensageiro	Conversas em tempo real, canais, urgência, fixar, tradução por mensagem, presença	Pronto
Agenda	Visual, arrastar com checagem de conflito, notas cifradas, risco de falta, SMS	Pronto
Teleconsulta	Vídeo Agora, janela flutuante, convite de especialista, consentimento e transcrição	Pronto; depende de conta Agora
Prontuário e caso clínico	Rascunho por IA, aprovação, SOAP, estudo de caso, familiograma e ecomapa	Pronto; IA exige revisão
Receitas e rotinas	Receita, atestado, pedido com QR verificável; rotinas por etapa via QR	Assinatura simples (sem ICP-Brasil)
Financeiro	Pacotes de sessões, pagamentos, inadimplência e exportação CSV	Pronto
Créditos e planos	Planos semanal/mensal, custos por função, tokens, embaixadores, PayPal	Pronto; cobrança desligada por padrão
Administração	Usuários, aprovação, redefinição de senha, integrações, auditoria, alertas de anomalia	Pronto
Instalador	Assistente no navegador, diagnóstico do servidor, testes de credenciais	Pronto; homologação em servidor real em curso
Cliente PWA	Instalável, 5 idiomas, desktop com post-its e dock	Pronto

Arquitetura em resumo

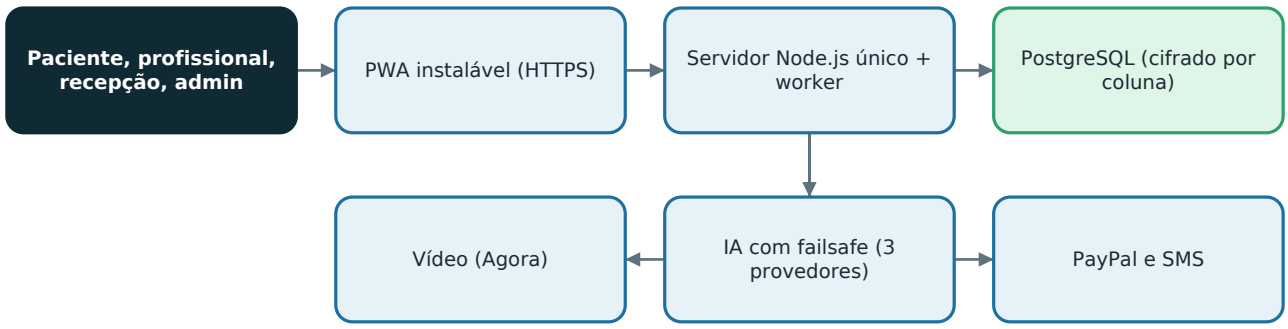


Figura 3.1 · Arquitetura. Detalhes na Documentação Técnica.

Custo de operar

A pilha é simples (um processo Node, um PostgreSQL, proxy): cabe em um VPS pequeno no início. Os custos variáveis relevantes são **IA**, **vídeo** e **SMS**, todos medidos por uso; por isso o produto já tem **créditos por funcionalidade** (custo configurável) para repassar ou limitar esse consumo.

4 Modelo de negócio e economia da unidade

Assinatura com créditos e aquisição por indicação

Planos de tabela (configuráveis pelo administrador)

Plano	Mensal	Semanal	Créditos/mês	Pacientes	Equipe	Vídeo (min/mês)	IA	Suporte
Básico	R$ 0	R$ 0	50	15	1	120	não	comunidade
Essencial	R$ 59	R$ 19	400	80	1	900	sim	e-mail
Profissional	R$ 149	R$ 45	1.500	400	3	3.000	sim + protocolos	prioritário
Clínica	R$ 399	R$ 119	6.000	3.000	15	15.000	sim + protocolos	dedicado

Receitas: (1) assinatura recorrente; (2) créditos adicionais para IA e vídeo; (3) planos semanais para sazonalidade e teste; (4) no futuro, serviços de implantação e integrações. Pagamento por PayPal (captura confere valor e moeda) ou pedido confirmado manualmente pelo administrador.

Aquisição incorporada ao produto

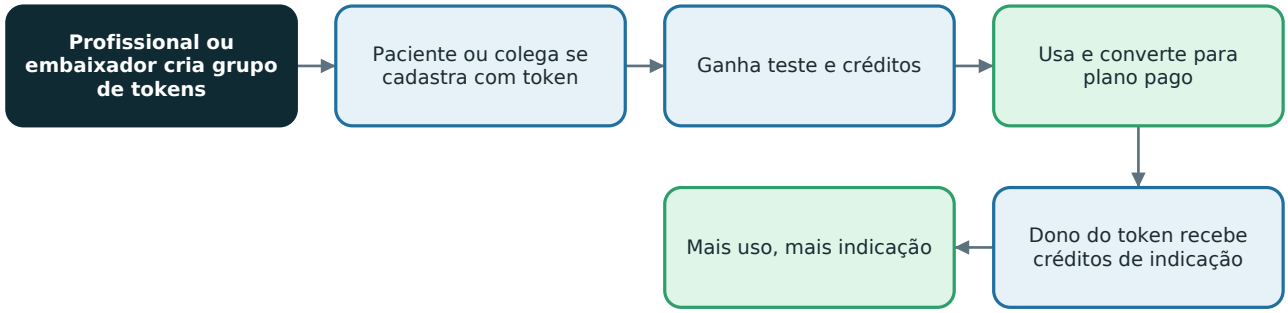


Figura 4.1 · Laço de indicação já implementado (token padrão TALK, tokens de promoção e de embaixador).

Simulação ilustrativa de receita recorrente

Contas feitas só com os preços de tabela e um mix de pagantes assumido. **Não são previsões**: servem para visualizar a sensibilidade ao mix e ao volume.

Cenário	ARPU mensal	100 pagantes	500 pagantes	2.000 pagantes
Mix A (60% Essencial, 30% Profissional, 10% Clínica)	R$ 120,00	R$ 12.000 /mês	R$ 60.000 /mês	R$ 240.000 /mês
Mix B (80% Essencial, 15% Profissional, 5% Clínica)	R$ 89,50	R$ 8.950 /mês	R$ 44.750 /mês	R$ 179.000 /mês

Tabela 4.1 · MRR = pagantes × ARPU. Receita anual (ARR) = MRR × 12. Ex.: Mix A com 500 pagantes ≈ R$ 60.000/mês.



Figura 4.2 · MRR do Mix A (R$ mil por mês).

Indicadores que governam a economia

Indicador	Fórmula	Meta de referência (a calibrar)
Ativação	Contas que enviam mensagem e agendam em 7 dias ÷ cadastros	definir no piloto
Conversão para pago	Pagantes ÷ contas ativas	definir no piloto
MRR e NRR	Receita recorrente; retenção líquida (upgrades − cancelamentos)	NRR ≥ 100%
Churn logo	Clientes que cancelam ÷ clientes no início do mês	a medir
Margem de contribuição	Receita − custos de IA, vídeo, SMS, pagamento e suporte por cliente	a medir
CAC e payback	Custo de aquisição ÷ margem mensal por cliente	payback curto (meses)
Consumo de créditos	Créditos usados ÷ créditos do plano	sinal de upgrade (alto) ou de risco de churn (baixo)
Coeficiente de indicação	Novos cadastros por token ÷ clientes ativos	medir pelos tokens

Atenção: Enquanto não houver histórico real, as metas ficam “a calibrar”. O piloto (capítulo 5) deve produzir o primeiro conjunto de valores medidos.

5 Playbook de go-to-market

Do primeiro piloto à repetição de vendas

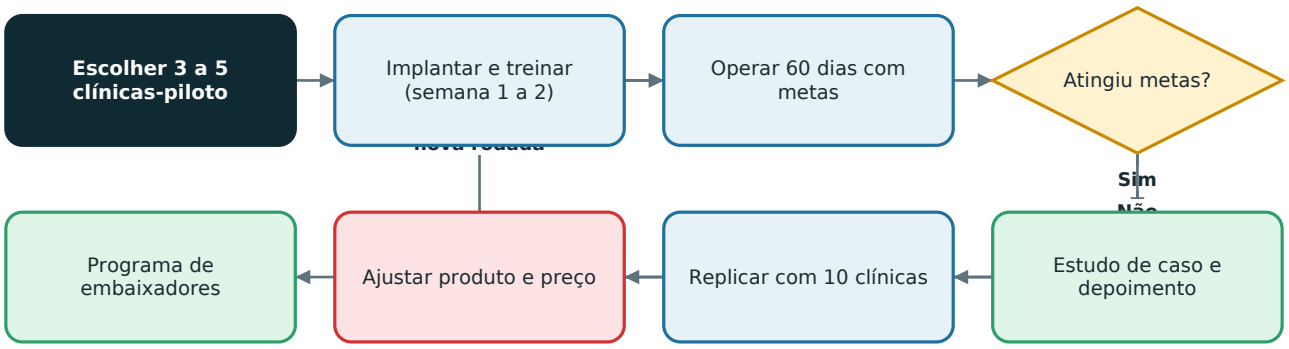


Figura 5.1 · Funil de validação comercial.

5.1 Piloto de 90 dias (passo a passo)

Semana	Ação	Entregável / critério
0	Selecionar clínicas pelo ICP; assinar termo de piloto e de tratamento de dados	Termo assinado; contato responsável
1	Instalação ou conta na nuvem; criar equipe e vincular pacientes; importar agenda	Todos os perfis acessam; auditoria verificada
2	Treinar por perfil com o Manual Ilustrado; ligar SMS e vídeo	100% da equipe fez login; 1ª teleconsulta
3 a 8	Uso real; reunião semanal de 20 min; coletar métricas	Ativação, faltas, uso do chat, tempo de prontuário
9 a 10	Medir contra metas; entrevistas com profissional, recepção e paciente	Relatório de resultados
11 a 12	Proposta comercial e conversão para plano	Decisão de compra; depoimento autorizado

Metas sugeridas do piloto (a ajustar com a clínica)

Meta	Como medir
≥ 70% dos profissionais usando semanalmente	Logins e mensagens por perfil
Redução de faltas em relação à linha de base	Status “faltou” antes e depois
≥ 50% das consultas com agenda no sistema	Agenda versus controle prévio
Satisfação ≥ 8/10 (equipe) e ≥ 8/10 (pacientes)	Pesquisa de 3 perguntas
Zero incidentes de privacidade	Alertas de anomalia e auditoria

5.2 Canais de aquisição (ordem de prioridade)

Canal	Como funciona	Por que prioriza
Indicação por tokens e embaixadores	Profissional gera grupo de tokens; ganha créditos por cada cadastro	Já implementado; custo de aquisição baixo
Parcerias com conselhos, sociedades e universidades	Webinars e piloto institucional	Credibilidade clínica e acesso a muitos profissionais
Conteúdo	Casos de uso (reabilitação, retorno), guias de LGPD e telemedicina	Atrai profissionais autônomos
Venda direta a clínicas	Demonstração de 30 min com dados fictícios (versão de demonstração existente)	Maior ticket (Clínica)
Parceiros locais (fronteira e Mercosul)	Revenda e implantação em espanhol e guarani	Expansão regional

5.3 Roteiro de venda (30 minutos)

- **Descoberta (8 min)**: como agenda, conversa e registra hoje? Quantas faltas por mês? Onde há risco de privacidade?
- **Demonstração (12 min)**: desktop, conversa com tradução, agenda com risco de falta, teleconsulta, rascunho de IA aprovado pelo profissional, receita com QR, auditoria.
- **Prova (5 min)**: privacidade (cifragem, vínculo, trilha) e implantação (instalador, servidor próprio).
- **Proposta (5 min)**: piloto de 90 dias no plano adequado e meta combinada.

5.4 Objeções frequentes

Objeção	Resposta
“Já uso WhatsApp.”	Mostre histórico cifrado por vínculo, agenda integrada e auditoria; WhatsApp não tem trilha nem controle de acesso por perfil.
“IA no prontuário é arriscado.”	A IA só gera rascunho; nada entra sem aprovação; nome do paciente é removido; há registro de quem aprovou.
“E a LGPD?”	Dados cifrados, acesso mínimo por vínculo, log de acessos e consentimento para IA e transcrição; contrato e DPO conforme capítulo 8.
“Minha equipe é pouco técnica.”	Interface de mensageiro, manual ilustrado por perfil, ajuda dentro do sistema e treinamento na semana 2.
“Quanto custa?”	Plano de tabela por tamanho; começa grátis; créditos só para recursos de IA e vídeo.

5.5 Política de preço e descontos

- Preço de tabela público; o sistema é a fonte única de preços (o cliente nunca informa valores).
- Descontos só por **compromisso** (anual) ou **volume** (várias unidades), nunca para “fechar mais rápido”.
- Piloto gratuito somente com termo, metas e prazo; depois converte ou encerra.
- Planos semanais para picos e cobertura de férias; migrar para mensal quando a recorrência se confirmar.

5.6 Cadência comercial

Ritmo	Atividade	Dono
Semanal	Pipeline: leads, demonstrações, pilotos; uso das contas em piloto	Comercial e sucesso do cliente
Quinzenal	Revisão de métricas de ativação e consumo de créditos	Produto
Mensal	MRR, churn, margem de contribuição, CAC/payback	Fundadores
Trimestral	Revisão de ICP, preços e roadmap	Fundadores e conselho

Resultados comerciais reais (leads, pilotos, clientes pagantes): **[preencher]**.

6 Playbook de implantação e operação

Como entregar, sustentar e escalar com segurança

6.1 Implantação de um novo cliente

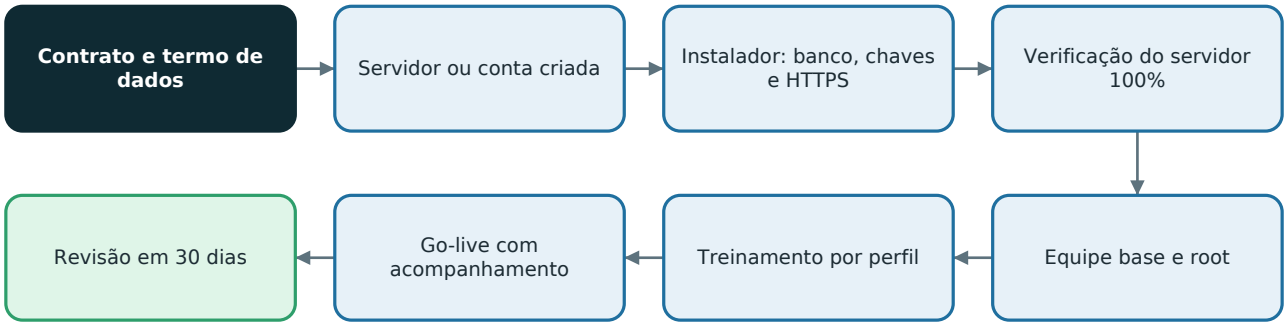


Figura 6.1 · Esteira de implantação.

Etapa	Checklist	Evidência
Servidor	Node 22+, PostgreSQL, proxy HTTPS com X-Forwarded-Proto e WebSocket, fuso correto	Tela de verificação sem pendência obrigatória
Chaves	DATA_KEY guardada em cofre e JWT_SECRET gerado	Cópia da DATA_KEY registrada
Integrações	Vídeo, IA (2 provedores), PayPal, SMS testados	Botão Testar verde
Equipe	Root com senha forte; administradores; vínculo paciente–profissional	Lista de usuários revisada
Cobrança	Decidir se liga BILLING_ENFORCE; planos e custos revisados	Regra definida em Gestão de créditos
Backup	pg_dump agendado e teste de restauração	Restauração testada e /api/audit/verify ok

6.2 Rotina de operação

Frequência	Tarefa	Responsável
Diária	Conferir /api/health, alertas de anomalia e mensagens de erro nos logs	Operação
Semanal	Revisar pedidos de plano, tokens e extrato de créditos; destravar contas	Administrador
Mensal	Rotacionar chaves expostas ou antigas; revisar usuários inativos; teste de restauração	Operação e segurança
A cada release	npm run check, npm test, homologação, aumentar versão do cache da PWA	Engenharia
Trimestral	Verificar a cadeia de auditoria; revisar permissões por perfil e provedores de IA	Segurança e fundadores

6.3 Resposta a incidentes

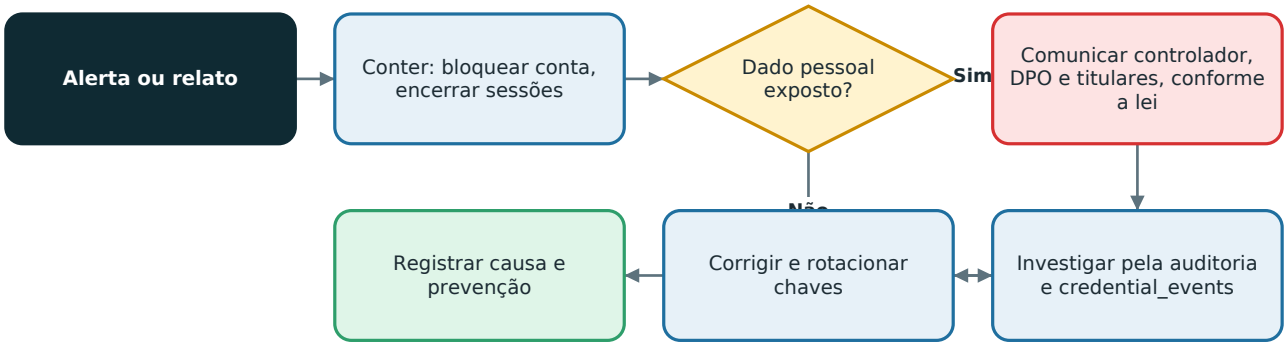


Figura 6.2 · Fluxo de incidente. Prazos e formalidades de comunicação devem seguir orientação jurídica.

6.4 Níveis de suporte

Plano	Canal	Meta de resposta (a definir em contrato)
Básico	Comunidade e manuais	sem compromisso
Essencial	E-mail	dia útil
Profissional	Prioritário	prazo reduzido
Clínica	Dedicado	conforme contrato

7 Roadmap de 18 meses

Proposta de priorização, sujeita à validação dos fundadores

O roadmap segue a ordem: **provar** (homologar e piloto), **proteger** (conformidade e confiabilidade), **crescer** (canais e integrações) e **expandir** (regiões e novos segmentos). As datas são relativas ao mês 1 (M1) da rodada.

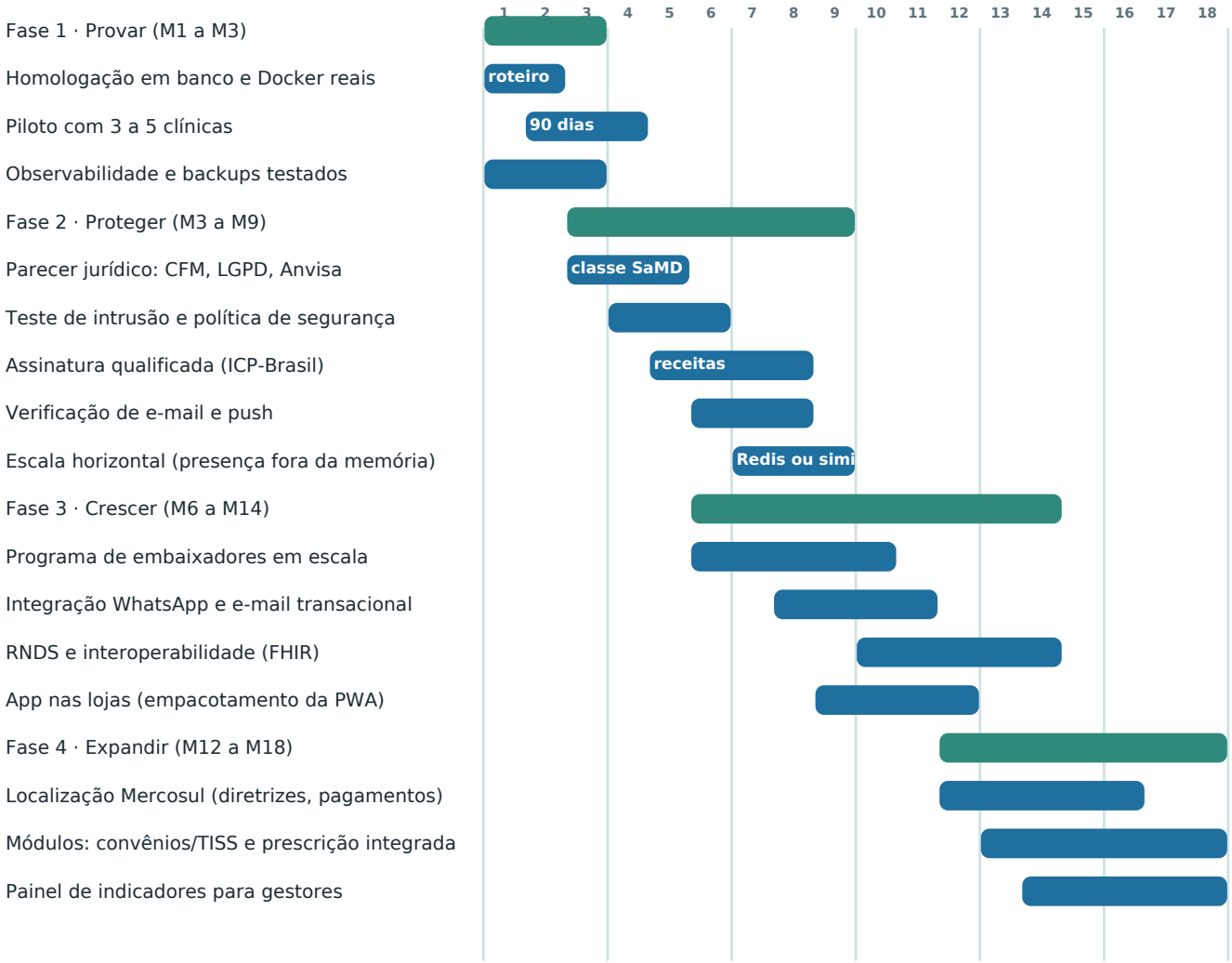


Figura 7.1 · Linha do tempo proposta. Barras escuras são fases; azuis, entregas.

Critérios de saída de cada fase

Fase	Critério de saída
1 · Provar	Roteiro de homologação sem falha; ≥ 3 clínicas com uso semanal; métricas do piloto coletadas
2 · Proteger	Parecer jurídico em mãos; teste de intrusão sem achados críticos abertos; decisão sobre classe regulatória do módulo de IA
3 · Crescer	Canal repetível (≥ 30% de novos clientes por indicação); NRR ≥ 100% nos clientes do piloto
4 · Expandir	Primeiro cliente fora do Brasil em produção; dashboard de gestor em uso

Itens do backlog técnico já conhecidos (origem: limites declarados no produto)

Item	Motivo	Fase
Assinatura ICP-Brasil	Hoje é eletrônica simples (hash + QR)	2
Verificação de e-mail no cadastro	Hoje o e-mail não é verificado	2
Notificações push	Hoje só SMS e avisos na tela	2
Presença e WebSocket fora da memória	Hoje exige uma instância	2
Revisão humana das traduções (guarani)	Qualidade de idioma	3
Lista ampliada de interações medicamentosas	Hoje é lista curta	3
Homologação em ambiente real	Servidor de instalação, créditos e credenciais verificados por testes e sintaxe	1

Princípios de priorização

- **Segurança e conformidade antes de funcionalidade nova** quando houver conflito.
- **Pedido de cliente pago** pesa mais que ideia interna; pedido de piloto entra no ciclo seguinte.
- **Medir antes de construir**: cada item cita o indicador que deve mover.
- **Pequenas entregas** a cada duas semanas, com testes e manual atualizados.

8 Regulação, segurança e conformidade

O que a plataforma já atende e o que falta formalizar

Atenção: Este capítulo resume o cenário público e a postura técnica do produto. **Não é parecer jurídico.** A classificação regulatória do módulo de IA e as obrigações contratuais devem ser confirmadas por advogado especializado em saúde digital.

Norma	Do que trata	Postura do produto	Lacuna a fechar
CFM 2.314/2022	Telemedicina: teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoramento; prontuário e sigilo	Teleconsulta com consentimento, prontuário cifrado, trilha de acesso, documentos com identificação do médico	Parecer jurídico; fluxos de primeiro atendimento e contingência
CFM 2.454/2026 (IA)*	Uso de IA como apoio; decisão final do médico; comissão de IA em instituições	IA só gera rascunho com aprovação humana; nada é comunicado ao paciente sem o profissional	Confirmar texto oficial e prazos de vigência; classificação de risco do sistema
Anvisa RDC 657/2022	Software como dispositivo médico (SaMD), por classe de risco	Módulos de IA de apoio à decisão podem exigir enquadramento	Avaliar classe e necessidade de notificação ou registro antes de escalar a IA clínica
LGPD (Lei 13.709/2018)	Dados pessoais e sensíveis de saúde	Cifragem em repouso, acesso mínimo por vínculo, consentimento de IA, trilha de auditoria, exclusão do nome na IA	DPO, RIPD, contratos de operador, política de privacidade, retenção e direitos dos titulares
Assinatura de documentos	Validade jurídica de receitas e atestados	Assinatura eletrônica simples (hash, selo e QR)	Assinatura qualificada (ICP-Brasil) onde exigida

* Informação extraída de artigo de opinião de executivo do setor; confirmar nos textos oficiais antes de qualquer decisão (fontes no capítulo 11).

Controles técnicos já existentes

- Senhas com Argon2, mínimo de 12 caracteres, bloqueio por tentativas, revogação imediata de sessões, cookie httpOnly/SameSite.
- Cifragem AES-256-GCM em repouso; HTTPS obrigatório para produção; CSP sem scripts inline.
- Auditoria encadeada e imutável, com verificação; registro de eventos de credenciais; alertas de anomalia.
- Perfis (RBAC) e vínculo paciente–profissional; administrador e recepção sem acesso clínico.
- Instalação em servidor do próprio cliente (controle de localização dos dados).

9 Riscos e mitigação

Matriz de risco e plano de resposta

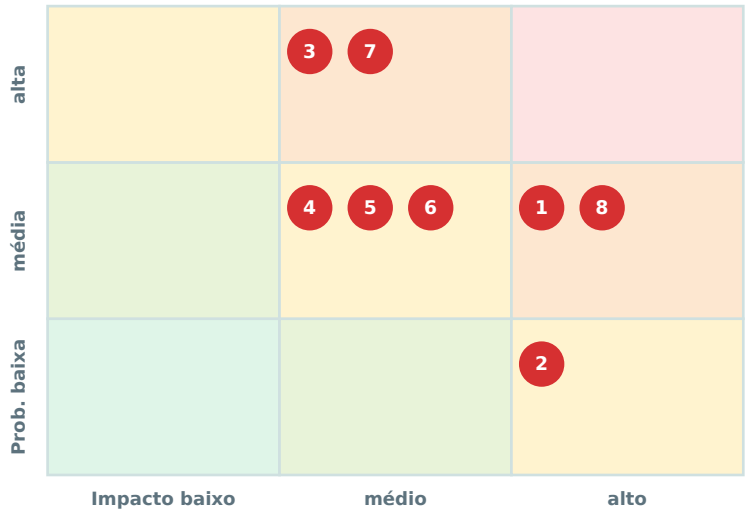


Figura 9.1 · Matriz de risco (probabilidade × impacto). Números correspondem à tabela.

#	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
1	Regulatório: classificação da IA como SaMD ou mudança de norma	Média	Alto	Parecer jurídico (fase 2); manter IA como apoio com aprovação; módulo de IA desligável por plano
2	Privacidade: incidente de dados	Baixa	Alto	Cifragem, mínimo acesso, auditoria, teste de intrusão, plano de incidentes, seguro cibernético
3	Adoção lenta por clínicas conservadoras	Alta	Médio	Piloto com metas, treinamento por perfil, plano grátis, indicação por tokens
4	Dependência de provedores (IA, vídeo, SMS, pagamento)	Média	Médio	Failsafe de IA com 3 provedores; contratos e alternativas de vídeo e SMS; custos por crédito
5	Escala técnica: uma instância e presença em memória	Média	Médio	Fase 2: presença externa e réplicas; monitoramento e limites de recursos
6	Custo variável de IA acima do previsto	Média	Médio	Créditos por função, limites por plano, cache de traduções, revisão mensal de margem
7	Concorrência de sistemas estabelecidos	Alta	Médio	Foco em nicho (reabilitação e clínicas pequenas), experiência de mensageiro, implantação independente
8	Dependência de poucas pessoas (risco de chave)	Média	Alto	Documentação técnica, manuais, testes, contratação e segundo mantenedor; cofre de chaves

10 Uso dos recursos e governança

Proposta de alocação e metas por marco

Tamanho da rodada e instrumento: **[preencher]**. A tabela abaixo é uma **proposta de distribuição percentual** coerente com o roadmap, para ser ajustada pelos fundadores.

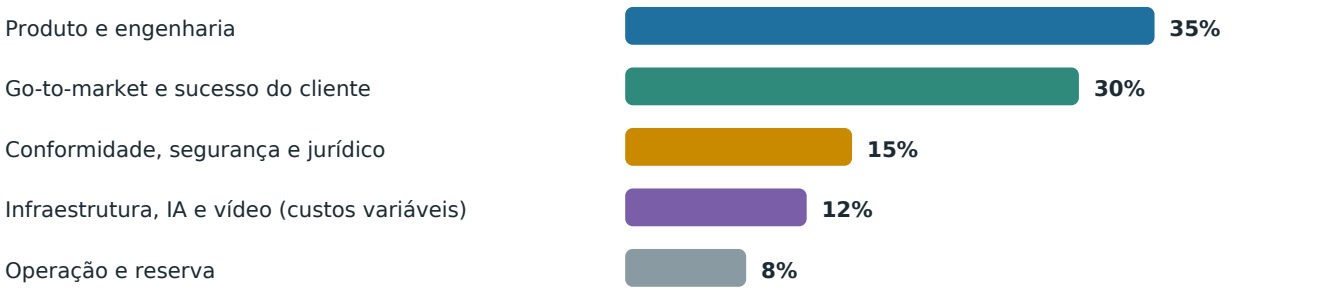


Figura 10.1 · Distribuição proposta (soma 100%).

Frente	Exemplos de gasto	Marco que destrava
Produto e engenharia	Assinatura qualificada, escala horizontal, integrações, app nas lojas	Fases 2 e 3
Go-to-market	Piloto, treinamento, conteúdo, parcerias, comissão de embaixadores	Fase 1 e 3
Conformidade e segurança	Parecer jurídico, DPO, teste de intrusão, seguro cibernético	Fase 2
Infraestrutura e IA	Servidores, backups, provedores de IA, vídeo e SMS	Todas
Operação	Contabilidade, suporte, reserva de caixa	Todas

Governança e relatórios

- Relatório mensal ao investidor: MRR, clientes, churn, NRR, margem de contribuição, uso de créditos, incidentes e marcos do roadmap.
- Revisão trimestral de ICP, preços e roadmap com conselho consultivo.
- Gestão das chaves (DATA_KEY e segredos): cofre com acesso duplo e teste de restauração semestral.

Equipe

Papel	Responsabilidade	Situação
Liderança de produto e clínica	Visão, regulação, parcerias clínicas	[preencher]
Engenharia	Plataforma, segurança, operação	[preencher]
Comercial e sucesso do cliente	Pilotos, vendas, treinamento, suporte	[preencher]
Jurídico e DPO	Conformidade, contratos	[preencher]

11 Due diligence e fontes

O que o investidor encontra e o que falta

Índice da sala de dados

Item	Conteúdo	Situação
Código-fonte	Repositório privado com histórico, testes e integração contínua	Existe
Manual do usuário ilustrado	35 páginas, todos os perfis	Existe
Documentação técnica	Arquitetura, API (158 rotas), banco (40 tabelas), implantação	Existe
Manual do investidor	Este documento	Existe
Relatório de homologação	Roteiro executado em banco e Docker reais	[a realizar]
Métricas de tração	Usuários, clínicas, MRR, retenção	[preencher]
Cap table, estatuto e acordos	Societário	[preencher]
Contratos e políticas	Termos de uso, privacidade, operador de dados, DPO	[preencher]
Parecer regulatório	CFM, LGPD, Anvisa	[a contratar]
Teste de intrusão	Relatório de terceiros	[a contratar]

Fontes consultadas (acesso em 12/11/2026)

- IMARC Group, Brazil Telemedicine Market (US$ 2,4 bi em 2025; US$ 12,9 bi em 2034; CAGR 20,52%): https://www.imarcgroup.com/report/pt-br/brazil-telemedicine-market
- CFM, Resolução 2.314/2022 (telemedicina): https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2022/2314_2022.pdf
- Medicina S/A, IA e diagnóstico: o que pode com as novas regras do CFM e Anvisa (artigo de opinião; resumo de CFM 2.454/2026 e RDC 657/2022; confirmar nos textos oficiais): https://medicinasa.com.br/ia-diagnostico-medico-cfm/
- U.S. International Trade Administration, Brazil Digital Health (investimento federal previsto de cerca de R$ 4,5 bi até 2026 em rede de hospitais inteligentes): https://www.trade.gov/market-intelligence/brazil-digital-health
- Dados do produto: código-fonte, configuração de planos (**billingLogic.js**) e documentação técnica do próprio Talk.M3D.

> **Aviso:** projeções de mercado são estimativas de terceiros e variam entre consultorias. Nenhuma informação deste documento garante resultado financeiro.